

Подростковый суицид, не пропусти сигналы...

Подростковый суицид сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Период подросткового возраста в психологии характеризуется как кризисный. Это момент перехода из детства во взрослую жизнь. Подросток — это уже не ребёнок, но ещё и не взрослый. У него появляется «чувство взрослости», а ценностей взрослой жизни, форм взаимодействия во взрослом мире ещё нет.

Своевременное выявление суицидального поведения и профилактика попыток самоубийства ложится в первую очередь на родителей и педагогов, хотя не менее важную роль в этой задаче играют педагоги-психологи и врачи-психиатры.

Наша статья в первую очередь ориентирована на родителей, которым необходимо знать следующие особенности отношения подростков к жизни и смерти:

1. Суицидальное поведение встречается у подростков чаще, чем в других возрастных группах. Это связано с рядом особенностей подросткового возраста. В этом возрасте реальная значимость проблемы и реакция на неё подростка могут быть доведены до катастрофической величины.
2. Суицидальные действия у подростков часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни.
3. Конфликтная ситуация ребёнка или подростка может складываться из незначительных, мимолётных (по мнению взрослых) неурядиц. Повышенная острота восприятия — черта, характерная для всех молодых людей, поэтому всё то, что кажется «глупостью» взрослым, может иметь для подростков решающее значение.
4. Дети подросткового возраста фактически отрицают смерть, экспериментируя с опасными веществами или будучи вовлечёнными в другую привлекательную, но рискованную активность. По мере взросления подросток принимает мысль о своей смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, отрицает реальность этой возможности. Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного исхода. В отличие от взрослых, у них отсутствуют четкие границы между истинной суицидальной попыткой и демонстративно-шантажирующим поступком.
5. Для подростков характерны внушаемость и стремление к подражанию. Поэтому когда случается одно самоубийство, оно становится сигналом к действию для других, предрасположенных к этому подростков. Иногда небольшие группы ребят даже объединяются с целью создания некой субкультуры самоубийств.

Специфика сложных жизненных ситуаций, конфликтных взаимоотношений с родителями и социальным окружением, личностные особенности подростка приводят к следующим типам суицидального поведения:

1. Демонстративное — без намерения покончить с собой. Попытки самоубийства организуются с расчётом на присутствие «зрителей», зачастую носят шантажно-

манипулятивный характер. Цель — быть услышанными, привлечь внимание к своим проблемам, получить помощь, добиться желаемого. Иногда действия заканчиваются смертью из-за просчетов плана.

2. Аффективное — суицидальные попытки, совершаемые на высоте аффекта (сильных эмоций). Аффект может длиться несколько минут, но иногда в силу напряженной ситуации растягивается на часы и сутки. В какой-то момент здесь может появиться мысль о том, чтобы расстаться с жизнью.

3. Истинное — обдуманное и постепенное выполнение намерения покончить с собой. Действия тщательно продуманы, просчитаны, являются четкой реализацией плана. Им предшествуют изменения мышления, высказываний, поведения. Решение принимается на основе долгих раздумий о смысле жизни, своём предназначении, бессмысленности существования.

К основным причинам суицидального поведения среди подростков относятся:

- внутрисемейные конфликты (развод родителей, ссоры и непонимание со стороны родителей и пр.);
- конфликты в школе (трудности усвоения материала, конфликты с педагогами, конфликты с одноклассниками);
- межличностные конфликты (в области дружеских или любовных отношений);
- потеря близкого человека (смерть, расставание);
- пережитое насилие (физическое, психологическое, сексуальное);
- психические заболевания.

Из вышеперечисленного на первое место среди оснований для совершения подростками самоубийства ставятся внутрисемейные конфликты. Вторым, не менее значимым побудителем детских самоубийств называются конфликты в школе, в образовательном учреждении.

Для подростка с его максимализмом, эгоцентричностью, неумением прогнозировать свою жизнь невнимательность и чѐрствость родителей создают ощущение безысходности, порождают чувство отчаяния, одиночества. При усилении конфликтов с родителями поведение ребёнка может ухудшаться, пропадает желание учиться, появляются апатия, вспышки гнева, протестные реакции. К сожалению, многими взрослыми такое состояние оценивается как лень, распушенность, последствия деструктивных методов воспитания. Подростков упрекают, стыдят, наказывают. Применяя различные меры воздействия на подростка, иногда слишком категоричные и даже агрессивные, родители «загоняют подростка в угол», превращают конфликтную ситуацию в суицидоопасную для подростка.

Именно поэтому родители должны быть очень внимательными и наблюдательными к изменениям в поведенческой и эмоциональной сферах личности ребёнка. Нарушение поведения, снижение успеваемости, конфликтность,

обидчивость, появление соматических нарушений могут быть проявлением депрессивного синдрома, который может привести к появлению суицидальных мыслей и намерений.

Основные симптомы депрессии в детском и подростковом возрасте, которые должны быть замечены родителями:

- уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека-одиночку;
- нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы (снижение успеваемости);
- погружённость в размышления о смерти и смысле жизни;
- отсутствие планов на будущее;
- внезапные приступы гнева или плача, зачастую возникающие из-за мелочей;
- пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное воспоминание неприятных событий прошлого;
- постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти;
- ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие;
- потеря аппетита или импульсивное обжорство;
- бессонница или повышенная сонливость;
- частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, постоянную усталость, частую сонливость);
- эгоцентрическая направленность на свои страдания;
- появление поведенческих трудностей — агрессивное поведение, непослушание, склонность к бунту, прогулы в школе, побеги из дома, злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Игнорирование подобных проявлений, отрицание самого факта возможности возникновения депрессивного состояния у подростка, надежда «на само пройдёт, перерастёт» или «надо его наказывать было» приводят зачастую к гибели ребёнка, которой можно было избежать даже с помощью внимательного «разговора по душам».

Когда мы говорим о школьных трудностях как о причине суицидального поведения подростка, стоит упомянуть распространённую проблему, приводящую к депрессивному состоянию и суицидальным проявлениям у подростка: буллинг — психологический террор, избиение, травля одного человека другим.

Различают четыре типа травли (буллинга) в школе, при этом они могут сочетаться друг с другом:

1. Вербальная агрессия. Ребёнка оскорбляют, называют обидными словами, смеются над ним, над особенностями его поведения, внешним видом.
2. Поведенческий террор. Одному ученику объявляют бойкот, от него изолируются, забирают его вещи, создают всевозможные условия, которые существование в коллективе делают невыносимым.
3. Физические издевательства. Ребёнку наносятся целенаправленные увечья, побои. Речь идёт о ситуации, когда один из противников более сильный, чем другой, а не о школьных драках.
4. Кибербуллинг. Издевательства происходят посредством социальных сетей, когда ребёнку отправляют оскорбительное сообщение или снимают ролики, в которых демонстрируются издевательства над жертвой, выкладывают их в социальной сети или на YouTube.

В случаях постоянного и жестокого буллинга дети могут рассматривать самоубийство как способ избежать страдания. Такие дети постепенно теряют надежду на позитивное решение проблемы. Их безнадёжность усиливается иррациональным мышлением, и смерть кажется единственным способом избавления от отчаяния и боли. Они рассуждают так: мои проблемы непреодолимы; даже те, кто мне дорог (близкие и родные), из-за моих проблем в школе находятся под давлением, поэтому мой уход из жизни может стать решением всех проблем для тех, кого я люблю. К сожалению, иногда и педагоги присоединяются к «затравливанию» ребёнка, что лишает его естественной помощи и поддержки с их стороны, усугубляя состояние и провоцируя на суицидальные действия.

Рекомендации родителям при взаимодействии с детьми:

1. Будьте внимательным слушателем. Не пытайтесь утешить общими словами типа «Ну, всё не так плохо», «Тебе станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте возможность ребёнку высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте своего ребёнка.
2. Открыто обсуждайте. Обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не бойтесь говорить об этом — большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает чувство отгороженности. Если ваш ребёнок находится в депрессии, не стесняйтесь спросить его, не подумывает ли он о самоубийстве и, больше того, не имеет ли он в голове уже готовый план.
3. Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьёз. Подростки часто отрицают, что говорили всерьёз, пытаются высмеять вас за излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьёз.

4. Подчёркивайте временный характер проблем — признайте, что его чувства очень сильны, проблемы сложны, — узнайте, чем вы можете помочь. Объясните ему, что он не единственный, кто попадает в сложную жизненную ситуацию. Покажите ему свою поддержку и заботу.

5. Окажите поддержку в успешной реализации ребёнка в настоящем, сделайте упор на его сильные стороны, предложите виды деятельности, в которых он может быть успешен. Помогите определить перспективу на будущее.

Дорогие родители, помните! Подростковый суицид можно предупредить, если вы будете внимательны к своему ребёнку. Нужно интересоваться его жизнью, но при этом не стараться слишком сильно влезать в неё, иначе ребёнок закроется ещё больше. Если вы заметили, что с вашим ребёнком творится что-то странное, нужно мягко, но настойчиво разговорить его и поддержать. Даже если он сделал что-то не так, сначала поддержите его, а уже потом разбирайтесь с последствиями.

Без родительской поддержки подросток часто опускает руки, и подростковый суицид кажется единственным решением проблемы. Поэтому очень важно, чтобы ваш ребёнок знал: вы любите его таким, какой он есть, и всегда поможет решить любую проблему. Уделяйте как можно больше внимания своим детям! Вам необходимо услышать то, что они хотят сказать, услышать их боль и отреагировать, дать понять, что выход всегда есть!

Литература

- Банников Г.С., Вихристюк О.В., Федунина Н.Ю. Применение технологии выявления факторов риска развития суицидального поведения среди подростков и молодежи // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23, № 4. URL: <http://psyjournals.ru/psyedu/2018/n4/>
- Методические рекомендации для педагогов-психологов образовательных организаций по диагностике факторов риска развития кризисных состояний с суицидальными тенденциями у обучающихся 7–11 классов / Под ред. Вихристюк О.В. — М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.
- Личко А.Е. Типы акцентуации характера и психопатий у подростков. — М., 1999. — 413 с.